ICS 11.020
CCS C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.15—2021
代替 GB/T 21709.15—2009

针灸技术操作规范　第15部分:眼针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 15:Ophthalmic acupuncture techniques

2021-12-31 发布　　2021-12-31 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　操作步骤与要求 …… 2
5　注意事项 …… 3
6　适应症 …… 3
7　禁忌 …… 3
附录 A（资料性）　眼针分区定穴图及眼针分区定穴方法 …… 4
附录 B（规范性）　眼针留针技术要求 …… 5
附录 C（规范性）　眼针留针的注意事项 …… 6
附录 D（资料性）　眼针技术治疗间隔及疗程 …… 7
附录 E（资料性）　眼针技术适应症 …… 8
附录 F（资料性）　眼针技术禁忌症 …… 9

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 21709《针灸技术操作规范》的第 15 部分。GB/T 21709 已经发布了以下部分:

——第 1 部分:艾灸;
——第 2 部分:头针;
——第 3 部分:耳针;
——第 4 部分:三棱针;
——第 5 部分:拔罐;
——第 6 部分:穴位注射;
——第 7 部分:皮肤针;
——第 8 部分:皮内针;
——第 9 部分:穴位贴敷;
——第 10 部分:穴位埋线;
——第 11 部分:电针;
——第 12 部分:火针;
——第 13 部分:芒针;
——第 14 部分:鍉针;
——第 15 部分:眼针;
——第 16 部分:腹针;
——第 17 部分:鼻针;
——第 18 部分:口唇针;
——第 19 部分:腕踝针;
——第 20 部分:毫针基本刺法;
——第 21 部分:毫针基本手法;
——第 22 部分:刮痧。

本文件代替 GB/T 21709.15—2009《针灸技术操作规范　第 15 部分:眼针》,与 GB/T 21709.15—2009 相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

——更改了眼针分区定穴方案,由“八区八穴”取代“八区十三穴”(见附录 A);
——更改了“眼针留针技术要求”的描述(见附录 B)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家中医药管理局提出。

本文件由全国针灸标准化技术委员会(SAC/TC 475)归口。

本文件起草单位:辽宁中医药大学附属医院。

本文件主要起草人:车戬、田维柱、海英、田原、张丝微、侯本赤、黄春元、张威、孙赫楠、程岩岩、柏强、刘加锌、裴莹、高峰、高嘉营、王天铎、张帆、郭莎莎、刘馨、赵曦彤、陈爱丽。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——2009 年首次发布为 GB/T 21709.15—2009;
——本次为第一次修订。

引　言

针灸技术操作规范是对各种针灸疗法操作程序、步骤、方法等方面所做的统一技术操作规定。在针灸技术操作规范方面，我国已经制定了系列标准 GB/T 21709。GB/T 21709《针灸技术操作规范》旨在确立普遍适用于针灸临床、教育、科研等方面关于针灸技术操作的工作准则，拟由 22 个部分组成。

——第 1 部分：艾灸。目的主要在于规范艾灸疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应艾灸实践发展新变化与新需求。

——第 2 部分：头针。目的主要在于规范头针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应头针实践发展新变化与新需求。

——第 3 部分：耳针。目的主要在于规范耳针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应耳针实践发展新变化与新需求。

——第 4 部分：三棱针。目的主要在于规范三棱针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应三棱针实践发展新变化与新需求。

——第 5 部分：拔罐。目的主要在于规范拔罐疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应拔罐实践发展新变化与新需求。

——第 6 部分：穴位注射。目的主要在于规范穴位注射疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应穴位注射实践发展新变化与新需求。

——第 7 部分：皮肤针。目的主要在于规范皮肤针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应皮肤针实践发展新变化与新需求。

——第 8 部分：皮内针。目的主要在于规范皮内针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应皮内针实践发展新变化与新需求。

——第 9 部分：穴位贴敷。目的主要在于规范穴位贴敷疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应穴位贴敷实践发展新变化与新需求。

——第 10 部分：穴位埋线。目的主要在于规范穴位埋线疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应穴位埋线实践发展新变化与新需求。

——第 11 部分：电针。目的主要在于规范电针疗法的相关概念、操作步骤与要求、适应症、注意事项、禁忌等，以适应电针实践发展新变化与新需求。

——第 12 部分：火针。目的主要在于规范火针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应火针实践发展新变化与新需求。

——第 13 部分：芒针。目的主要在于规范芒针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应芒针实践发展新变化与新需求。

——第 14 部分：鍉针。目的主要在于规范鍉针疗法的相关概念、操作步骤与要求、适应症、注意事项、禁忌等，以适应鍉针实践发展新变化与新需求。

——第 15 部分：眼针。目的主要在于规范眼针疗法的相关概念、操作步骤与要求、适应症、注意事项、禁忌等，以适应眼针实践发展新变化与新需求。

——第 16 部分：腹针。目的主要在于规范腹针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应腹针实践发展新变化与新需求。

——第 17 部分：鼻针。目的主要在于规范鼻针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应鼻针实践发展新变化与新需求。

——第 18 部分：口唇针。目的主要在于规范口唇针疗法的相关概念、操作步骤与要求、疗程与适应

症、注意事项、禁忌等，以适应口唇针实践发展新变化与新需求。

——第 19 部分：腕踝针。目的主要在于规范腕踝针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应腕踝针实践发展新变化与新需求。

——第 20 部分：毫针基本刺法。目的主要在于规范毫针基本刺法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应毫针基本刺法实践发展新变化与新需求。

——第 21 部分：毫针基本手法。目的主要在于规范毫针针刺手法的相关概念、施术方法、注意事项、禁忌等，以适应毫针基本手法实践发展新变化与新需求。

——第 22 部分：刮痧。目的主要在于规范刮痧疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应刮痧实践发展新变化与新需求。

针灸技术操作规范　第15部分:眼针

1　范围

本文件规定了眼针针灸技术操作的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项与禁忌。

本文件适用于眼针针灸技术操作。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

眼针技术　ophthalmic acupuncture skills

在眼眶内外特定的穴区进行针刺等刺激,以治疗疾病的方法。

3.2

眼针穴区　the acupoint area for ophthalmic acupuncture

眼针疗法中,其相关穴位所分布的区域。

3.3

眼针分区定穴图　the acupoint-selecting standard of ophthalmic acupuncture

眼针技术所遵循的穴区选择标准。

注:眼针分区定穴图见附录A。

3.4

眶内直刺法　vertical insertion within the orbital cavity

持针在紧贴眼眶内缘的穴区,垂直进针的操作方法。

3.5

眶外平刺法　horizontal insertion outside the orbital cavity

在距眼眶内缘2 mm的眼眶部位,选取穴区进行平刺操作的方法。

3.6

点刺法　pricking acupuncture

在穴区所对应的眼睑部位,进行点刺操作的方法。

3.7

双刺法　double insertion

在同一穴区内,连续刺入两针的操作方法。

3.8

眶内外合刺法　successive insertion within and outside the orbital cavity

于所选取的穴区内,在眶内、眶外各刺一针的操作方法。

3.9

压穴法　acupoint-pressing therapy

于所选取的穴区内，对眼眶内缘进行点压刺激的操作方法。

4　操作步骤与要求

4.1　施术前准备

4.1.1　针具选择

宜用 29 号～33 号(0.2 mm～0.35 mm)，0.5 寸～1 寸(15 mm～25 mm)的一次性毫针。所选择的毫针针身应光滑、无锈蚀，针尖应锐利、无倒钩。

4.1.2　部位选择

在眼眶内外，选取穴区进行操作。

4.1.3　体位选择

选择患者舒适，医者便于操作的治疗体位。

4.1.4　环境要求

环境应清洁卫生，避免污染。

4.1.5　消毒

4.1.5.1　针具消毒

应选择高压蒸汽消毒法。

4.1.5.2　部位消毒

应用含 75%医用乙醇或 0.5%～1%碘伏的棉签或棉球在施术部位消毒。

4.1.5.3　医者消毒

医者双手宜先用肥皂水清洗干净，再用含 75%医用乙醇或 0.5%～1%碘伏棉球擦拭。

4.2　施术方法

4.2.1　眶内直刺法

以押手固定眼球，持针在紧贴眼眶内缘的穴区，垂直进针 0.5 寸(15 mm)。

4.2.2　眶外平刺法

持针在距眼眶内缘 2 mm 的穴区部位，进行平刺操作，刺入真皮，达至皮下组织，进针 0.5 寸(15 mm)，保持针体处于该穴区内。

4.2.3　点刺法

以押手固定眼睑，使之绷紧，持针在眼睑部选取穴区轻轻点刺 5 次～7 次，以不出血为度。

4.2.4　双刺法

不论采取眶内直刺法或眶外平刺法，当刺入一针后，在其所处的穴区内，紧贴着针体旁，按同一方

向，再刺入一针，均进针 0.5 寸(15 mm)。

4.2.5 眶内外合刺法

于同一穴区内，在眶内、眶外各刺一针，均进针 0.5 寸(15 mm)。

4.2.6 压穴法

于所选取的穴区内，使用点穴棒、三棱针柄等，按压眼眶内缘，以局部产生酸、麻、胀感为度，持续按压 15 min～30 min。

4.3 施术后处理

4.3.1 行针技术的操作要求

一般情况下，进针后不需行针，无需提插、捻转；如果进针后针感不明显，可施以刮柄法或将针体提出 1/3，稍改变方向后再行刺入。

4.3.2 留针技术要求

留针技术要求按附录 B 执行。

4.3.3 留针的注意事项

留针的注意事项按附录 C 执行。

4.3.4 出针的要求

以刺手的拇、食二指捏持针柄，轻轻转动后缓慢出针 1/2，然后慢慢拔出，拔针后即刻用干棉球按压针孔，宜按压 1 min～3 min。

眼针技术治疗间隔及疗程见附录 D。

5 注意事项

5.1 注意发生晕针或晕血。
5.2 注意发生局部出血或血肿。
5.3 注意进针时伤及眼球。
5.4 点刺操作时，进针宜浅，手法宜轻、宜快。
5.5 注意防止操作部位感染。
5.6 孕妇及新产后慎用眼针疗法。
5.7 患者精神紧张、大汗后、劳累后或饥饿时慎用本疗法。
5.8 震颤不止，躁动不安，眼睑肥厚者慎用。

6 适应症

眼针技术适应症见附录 E。

7 禁忌

眼针技术禁忌症见附录 F。

附　录　A
（资料性）
眼针分区定穴图及眼针分区定穴方法

A.1　眼针分区定穴图

见图 A.1。

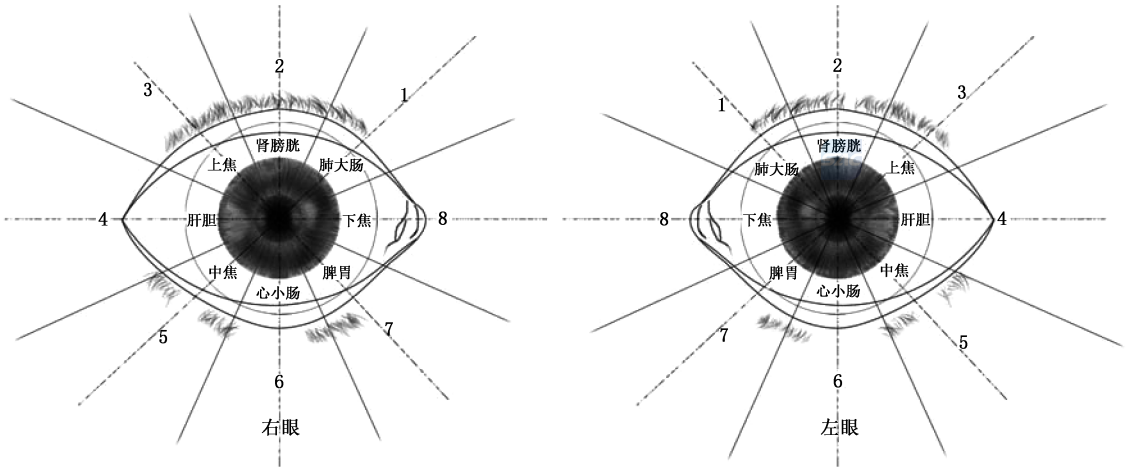

图 A.1　眼针分区定穴图

A.2　眼针分区定穴方法

双眼平视正前方，以瞳孔为中心作水平线及垂线，即从瞳孔发出的上、下、内、外 4 条线将眼球等分为 4 个区域，再将该 4 个区域各引一条平分线，此时以瞳孔为中心的 8 条线将眼球等分为 8 个区域，该 8 条线称为分区定位线，内上方的平分线为分区定位 1 线；瞳孔正上方的垂线为分区定位 2 线；外上方的平分线为分区定位 3 线；瞳孔至目外眦的水平线为分区定位 4 线；外下方的平分线为分区定位 5 线；瞳孔正下方的垂线为分区定位 6 线；内下方的平分线为分区定位 7 线；瞳孔至目内眦的水平线为分区定位 8 线。

再以瞳孔为中心发出 8 条平分线，将上述 8 个区域等分为 16 个小区域。分区时，以分区定位 1 线为中心，将其邻近的 2 个小区域划分为 1 区；以分区定位 2 线为中心，将其邻近的 2 个小区域划分为 2 区；同理，陆续可以划分 3 区～8 区。

定穴时，沿自 1 区至 8 区的方向，划分如下：1 区为肺大肠区；2 区为肾膀胱区；3 区为上焦区；4 区为肝胆区；5 区为中焦区；6 区为心小肠区；7 区为脾胃区；8 区为下焦区。

附　录　B
（规范性）
眼针留针技术要求

B.1　静置留针法

留针期间不应施行任何针刺手法，让针体留置在穴区内。一般情况下，留针时间宜在 15 min～60 min。

B.2　刮柄刺激法

留针期间内，如果局部得气感不明显，则可间歇重复施行刮柄法，以加强刺激。一般情况下，在 15 min～30 min 内，宜间歇行针 1 次～2 次，每次 0.5 min～1 min。

附　录　C
（规范性）
眼针留针的注意事项

C.1　留针应因人而宜，体弱者留针时间较短，体壮者可适当延长留针时间。婴幼儿和躁动患者，以及其他难于合作者，不宜留针。

C.2　留针应因时而宜，夏季天气炎热，不宜久留针；冬季气候寒冷，适宜久留针。

C.3　留针应因病而宜，病情轻、症状轻或经治疗症状已消失者，可以不留针或短时间留针；病情重，症状顽固者宜久留针。

C.4　留针应注意安全，留针期间应叮嘱患者及家属不要碰触留置在眼眶内外的毫针，以免折针、弯针。对需要长期留针而又有严重心脑血管疾病者，应加强监护，以免发生意外。

附　录　D
（资料性）
眼针技术治疗间隔及疗程

眼针技术治疗时，宜每日 1 次，连续治疗 10 d～14 d 为 1 个疗程，休息 2 d 后，可进行下一疗程。

附　录　E
（资料性）
眼针技术适应症

下列疾病可选用眼针疗法：

a）内科：中风病、中风先兆、头痛、眩晕、面瘫、失眠、颤证、高血压、三叉神经痛、膈肌痉挛、血管性痴呆、抑郁症、癫痫、重症肌无力、眼肌麻痹、不安腿综合征、格林巴利综合征、支气管哮喘、面肌痉挛、运动神经元病、2 型糖尿病、动眼神经麻痹、糖尿病缺血性视神经病变、痛风性关节炎、胆囊炎、胆绞痛、溃疡性结肠炎、急性胃肠炎、胆道蛔虫症、贲门失弛缓症、便秘、肠易激综合征、遗尿、肾、输尿管绞痛、干燥综合征、抑郁症、癔病性瘫痪等；

b）骨伤科：颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症、腰椎骨质增生、急性腰扭伤、坐骨神经痛、落枕、膝关节炎、软组织损伤等；

c）妇科：痛经、月经不调、产后尿潴留、功能性子宫出血、经期头痛、乳癖等；

d）儿科：疳积、小儿腹泻、百日咳、孤独症儿童目光交流障碍、小儿抽动-秽语综合征、小儿遗尿症、痉挛型脑性瘫痪患儿合并智力障碍等；

e）皮肤科：黄褐斑、蝴蝶斑、痤疮、美容、带状疱疹等；

f）外科：肾结石、胆结石、血栓性闭塞性脉管炎、混合痔术后疼痛、脑外伤、脑外伤后偏瘫、脑外伤后奇异步态、脑外伤认知功能障碍、外伤后动眼神经麻痹、外伤癃闭、外伤性腰痛等；

g）五官科：突发性耳聋、中心性视网膜炎、复视、干眼症、近视、眼肌麻痹、弱视、近视眼并发白内障、视疲劳、过敏性鼻炎等。

附　录　F
（资料性）
眼针技术禁忌症

F.1　眼区有破损感染者禁用。

F.2　精神病患者禁用。

F.3　传染病患者禁用。

F.4　金属过敏者禁用。